

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Δ-ΔΙΜΕΡΩΝ

Τα Δ-Διμερή (*D-Dimers*) αποτελούν τα προϊόντα διάσπασης της ινικής, δηλαδή ουσιαστικά ανιχνεύουν τους θρόμβους που βρίσκονται στη φάση της λύσης. Τα D-dimers είναι τα μικρότερα πρωτεϊνικά θραύσματα από τη διάλυση του ινώδους (με τη δράση της Πλασμίνης), το οποίο υπάρχει στον ερυθρό θρόμβο. Η εργαστηριακή (ή παρά κλίνη) μέτρηση των D-dimers αξιολογεί το βαθμό ενεργοποίησης του ινωδολυτικού συστήματος και την ενδαγγειακή θρόμβωση.

Αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο για τον αποκλεισμό της οξείας φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου, όπως της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (*DVT*) ή της πνευμονικής εμβολής (*PE*). Η μέτρηση των επιπέδων D-Dimers, μαζί με άλλες εξετάσεις (*PLT, Fib, a-PTT, PT, FDP, LDH, κ.ά.*) χρησιμοποιείται και στη διάγνωση της διάχυτης ενδαγγειακής πήξης (*DIC*).

Έτσι λοιπόν, έχουν ευρέως χρησιμοποιηθεί για τον αποκλεισμό της πνευμονικής εμβολής, καθώς παρουσιάζουν υψηλή αρνητική προγνωστική αξία επί οξέων περιστατικών με χαμηλή ή μέτρια κλινική πιθανότητα για πνευμονική εμβολή. Σε ασθενείς με υψηλή κλινική υποψία για PE συνεπικουρεί την απόφαση για περαιτέρω έλεγχο με αξονική πνευμονική αγγειογραφία (*CTPA*).

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι τα D-dimers ανευρίσκονται αυξημένα και στις περιπτώσεις οξέος διαχωριστικού ανευρύσματος της αορτής (*AAD*). Κατά τα τελευταία χρόνια, διεξάγονται ευρείες κλινικές μελέτες, οι οποίες σκοπό έχουν να καθιερώσουν τα D-dimers ως την εξέταση αποκλεισμού (*αρνητική προγνωστική αξία*) του οξέος διαχωριστικού ανευρύσματος της αορτής.

Σε ασθενείς με Covid-19, τα αυξημένα επίπεδα D-dimers διαπιστώθηκε ότι συσχετίζονται με τη βαρύτητα της νόσου, αλλά και με τη θνησιμότητα, αντικατοπτρίζοντας την πηκτική διαταραχή και τον υψηλό κίνδυνο θρόμβωσης που παρατηρήθηκε σε πολλούς ασθενείς με νόσο Covid-19.

Τα D-dimers εκτός των προαναφερθέντων, ανιχνεύονται σε πλήθος άλλων παθολογικών ή μη καταστάσεων (βλ. πίνακα) και η κλινική αξιολόγηση τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Φυσιολογικές τιμές – ανάλογα με την εκάστοτε μέθοδο μέτρησης – θεωρούνται όταν:
D-dimers < 250 μg/l (ng/ml) ή D-dimers < 1,35 nmol/l ή D-dimers < 0,5 μ/ml.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ	
Αγγειακά αίτια	Φλεγμονώδη αίτια
• Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (DVT). • Πνευμονική εμβολή. • Αορτικός διαχωρισμός. • Ανευρύσματα & Αγγειοδυσπλασίες. • Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη (DIC). • Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). • Ισχαιμία άκρου (<i>περιφερική αρτηριοπάθεια</i>). • Μεσεντέριος ισχαιμία. • Τραύμα & χειρουργικές επεμβάσεις. • Έγκαυμα & Εγκαυματική νόσος. • Θρομβολυτική θεραπεία. • Δρεπανοκυτταρική νόσος (<i>ειδικά στη φάση της οξείας δρεπανοκυτταρικής κρίσης</i>). • Σύνδρομο HIT type-2.	• Σοβαρές φλεγμονές - Σήψη. • ARDS. • Λοίμωξη Covid-19. • Ερυσίπελας. • Νεφρικά νοσήματα. • Ηπατικά νοσήματα. • Αιμόλυση. • Κολπική μαρμαρυγή / πτερυγισμός. • Προεκλαμψία / Εκλαμψία (<i>σύνδρομο HELLP</i>). • Χρόνιες φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου. • Νοσήματα συνδετικού ιστού (<i>PA, ΣΕΛ, κ.ά.</i>). • Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. • Κακοήθειες (<i>π.χ. μαστού, πνεύμονος, προστάτη, ωοθηκών, π. εντέρου, εγκεφάλου, λεμφώματα</i>). • Υπερτριγλυκεριδαμία / Παγκρεατίτιδα.
ΜΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ	
▶ Προχωρημένη ηλικία ασθενούς. ▶ Ασθενείς χρονίως κατακεκλιμένοι. ▶ Μετεγχειρητική περίοδος. ▶ Μετατραυματική περίοδος.	▶ Μεταλοιμώδης περίοδος. ▶ Εγκυμοσύνη & Λοχεία. ▶ Κάπνισμα. ▶ Μαύροι πληθυσμοί.